Region Uppsala

AKADEMISKA SJUKHUSET

CEX
Clinical Evaluation Exercise

ST-läkare

Observatör & Befattning

Verksamhet & Sektion

Nuvarande fas i
☐ ST eller ☐ Placering

BÖRJAN ☐ MITTEN ☐ SLUTET ☐

Datum

Kort beskrivning av
Ämne/situation

Karaktär av situation ☐ Akut ☐ Icke-akut ☐ Ej relevant

Plats ☐ Akuten ☐ Mottagning ☐ Operation ☐ Fri text

Fokus för aktivitet ☐ Klinisk handläggning ☐ Anamnes ☐ Status ☐ Organisation/Ledning ☐ Kommunikation med medarbetare ☐ Kommunikation med patient

Självreflektion

Upplevd svårighetsgrad ☐ Lätt ☐ Ordinärt ☐ Komplext

Styrkor

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Lärdomar

Egna förslag för att uppnå förbättring

Återkoppling från observatör

Upplevd svårighetsgrad ☐ Lätt ☐ Ordinärt ☐ Komplext

Styrkor

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Tillvägagångsätt för att uppnå förbättring

Delmoment – Skattning av självständighet

Observationen innefattar inte nödvändigtvis alla delmoment som då kan markeras som "ej relevant"

	*Milstolpar**				Ej Relevant
1. Anamnes	☐	☐	☐	☐	☐
2. Status	☐	☐	☐	☐	☐
3. Teoretisk kunskap	☐	☐	☐	☐	☐
4. Klinisk handläggning	☐	☐	☐	☐	☐
5. Adekvata kliniska/diagnostiska slutsatser	☐	☐	☐	☐	☐
6. Kommunikation med patient	☐	☐	☐	☐	☐
7. Kommunikation med medarbetare	☐	☐	☐	☐	☐
8. Ledarskapsförmåga	☐	☐	☐	☐	☐
9. Organisationsförmåga	☐	☐	☐	☐	☐
10. Professionellt förhållningssätt	☐	☐	☐	☐	☐

Milstolpar*



Skriv ut Rensa

CEX Instruktioner

Beskrivning
En clinical evaluation exercise är en observation som utförs under ST-läkarens utförande. Det kan innefatta flera olika moment som t.ex. anamnes, status, kommunikation, ledarskap eller teamwork. Det är dvs inte bara en observation av ST-läkaren i en konsultation med en patient, utan även andra professionella förhållanden som är en del av läkaryrket.

Exempel

- Ta anamnes och status
- Informera patient om svåra/dåliga besked
- Ta samtycke inför operation/studieinklusion/ingrepp
- Leda rond/möte
- Utbilda kollegor/Coaching
- Konfliktresolution
- Leda mottagning

Observatör och befattning
Observationerna ska utföras flertal gånger och av olika observatörer. Ju fler observationer som görs, samt av olika kollegor, desto mer tillförlitligt blir resultatet. Fler observationer innebär också mer och varierad återkoppling till ST-läkaren, vilket är positivt ur ett pedagogiskt perspektiv. Befattning (specialist eller överläkare) ska inkluderas för att säkerställa att ST-läkaren observeras av seniora kollegor med olika grad av erfarenhet.

Verksamhet & Sektion
Vid ST-läkarens egna och randande specialistområden finns det ofta olika verksamheter (eller ämnesområden) och ibland även specifika sektioner. Om detta finns så ska det specificeras som t.ex. följande

Verksamhet	Övre bukkirurgi	Mikrokirurgi	Lungmedicin
Sektion	Lever-Galla-Pankreas	Bröstrekonstruktion	Astma

Nuvarande fas i ST eller Placering
Beroende på hur ST-läkarens ST-utbildning är upplagd vid enskild klinik, så kryssas rutan som bäst beskriver vart ST-läkaren befinner sig i relation till planerad erfarenhet av den specifika verksamheten i vilken observationen sker. Planeras observationen som återkommande under hela ST-utbildningen så kryssas ”ST”. Är observationen en del i en specifik placering inom verksamheten eller sidotjänstgöring så är det ofta att man endast har möjligheten till att utföra observationen under en specifik tidsram, och man kryssar då i ”Placering” för att inte förväxla fas i ST, med självständighetsgrad i en specifik placering eller randning som ofta sker oberoende av varandra.

Ämne/situation
Ämne ska vara en kort mening som ger en snabb och tydlig bild av temat för observationen

Exempel
- Konsultation – Akut buk
- Leda morgonrond
- Ta samtycke inför operation
-

Plats
Där ST-läkarens utförande har ägt rum

Karaktär av situation
Vid patientbemötande – om fallet gällt en patient i ett akut tillstånd eller ej

Självskattning

Här ska ST-läkaren ge sin bild av hur man har presterat i observationen. Delmomenten finns som stöd som diskussionsunderlag.

Upplevd svårighetsgrad av fall

ST-läkaren ska göra en skattning av komplexitet-graden av utgångspunkten för observationen

Styrkor

Här ska ST-läkaren specificera styrkor i sitt utförande

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Här ska ST-läkaren ge en kort beskrivning, helst i punktform, av specifika aspekter i utförandet som man själv tycker ska utvecklas

Lärdomar

Här ska ST-läkaren presentera specifika punkter som man har lärt sig från sin egna reflektion och diskussion med observatör.

Egna förslag för till att uppnå förbättring

Här ska ST-läkaren ge en kort beskrivning, helst i punktform av hur man ska uppnå förbättring. T.ex. läsa igenom regelverk/riktlinjer, gå en kurs, läsa på anatomi, simuleringsträna ingreppet

Återkoppling från observatör

Här ska observatören ge sin bild av hur man har presterat i observationen. Delmomenten finns som stöd som diskussionsunderlag.

Svårighetsgrad av fall

Observatören ska göra en skattning av komplexitet-graden av utgångspunkten för observationen

Styrkor

Här ska observatören presentera specifika punkter som framförts bra t.ex. hur presentationen av fallet getts och hur det kliniska omdömet och resonemanget resulterat i hur man slutligen resonerat.

Kunskaper/färdigheter/förhållningssätt som kan förbättras

Här ska observatören ge en kort beskrivning, helst i punktform, av specifika aspekter i resonemanget som man bör utvecklas.

Tillvägagångssätt för att uppnå förbättring

Här ska observatören ge en kort beskrivning, helst i punktform, av hur ST-läkaren ska uppnå förbättring. T.ex. läsa igenom regelverk/riktlinjer, gå en kurs, läsa på anatomi, simuleringsträna ingreppet

Delmoment – förklarande text

Om delmoment är relevant för observationen så ska observatören göra en skattning. Om ej relevant så ska man kryssa i "Ej relevant". Skattningen av delmoment ska göras enligt skalan av milstolpar och graderas från behovet av vägledning som ST-läkaren behöver i sitt resonerande eller framlägg av fall och klinisk information.

1. **Anamnes**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att självständigt ta en adekvat anamnes inom en konsultation

2. **Status**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att självständigt ta ett adekvat och korrekt status inom en konsultation

3. **Teoretisk kunskap**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att självständigt

4. **Klinisk handläggning**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att lägga upp en korrekt handläggning och en patientsäker uppföljning. Detta kan inkludera labb- och röntgenprover eller remiss till annan specialitet, och förutsätter en adekvat anamnes och status.

5. **Adekvata kliniska/diagnostiska slutsatser**
   Här ska ST-läkarens förmåga att förankra teori med klinik skattas dvs förmågan att tillämpa sina teoretiska kunskaper i den aktuella kliniska situationen (t.ex. diagnos, allvarlighetsgrad, åtgärd)

6. **Kommunikation med patient**
   ST-läkarens förmåga av både kroppsspråk och muntlig kommunikation, samt lyssnarförmåga, med patient

7. **Kommunikation med medarbetare**
   ST-läkarens förmåga av både kroppsspråk och muntlig kommunikation, samt lyssnarförmåga, med teamet

8. **Ledarskapsförmåga**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att uppvisa ledarskap i sitt utförande. Specifika färdigheter är t.ex. samarbete, problemlösning, lyssnarförmåga, flexibilitet, delegering, teamwork

9. **Organisationsförmåga**
   Här skattas ST-läkarens förmåga att planera moment eller individer, resurser, miljö, samt tidsplanering

10. **Professionellt förhållningssätt**
    Om relevant för fallet, så ska här ST-läkarens förmåga att uppvisa ett professionellt förhållningssätt skattas. Specifika färdigheter är t.ex. patientcentrerat förhållningssätt, evidensbaserad bedömning, uppriktighet och empati, förmåga att veta sina begränsningar, kommunikationsförmåga i relation till patienter/kollegor/medarbetare

Milstolpar - Förklarande text

